

39. 腸管係蹄の発生

所要時間 : 20:47

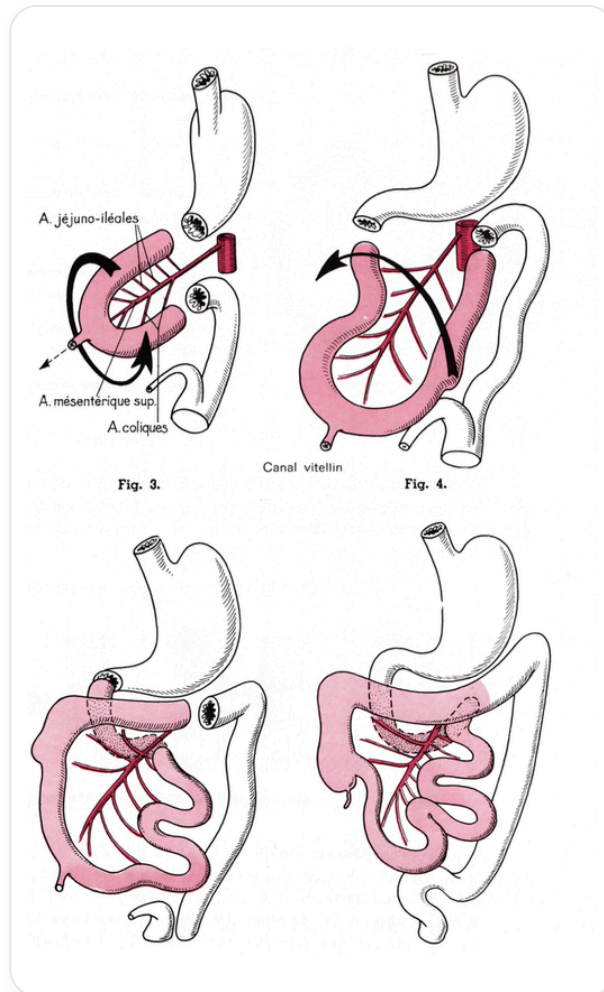
学習シート

コース概要

このビデオでは、腸管の胚発生の深化について、腸の反時計回りの回転、上腸間膜動脈の重要性、およびそれが腸の成長ダイナミクスに与える影響に焦点を当てて説明します。取り上げられる主要な概念には、胃、肝臓、心臓の関係、および腸の発達と機能に不可欠なさまざまな支持点が含まれます。さらに、このビデオでは、感情と腸の健康との関連性を探り、怒りや恐怖などの感情が消化にどのように影響するかを詳しく説明します。また、腸疾患の治療において腹膜のダイナミクスを考慮することの重要性も学び、オステオパシーにおける治療アプローチを豊かにします。

腸管係蹄の発生

臍帯は最初大きいですが、発生とともに縮小していきます。当初、**腸**は腹腔外で発生します。これは、主に**上腸間膜動脈**によって供給される多量の**栄養供給**によるものです。大動脈から分岐するこの動脈は、腸の回転軸となります。

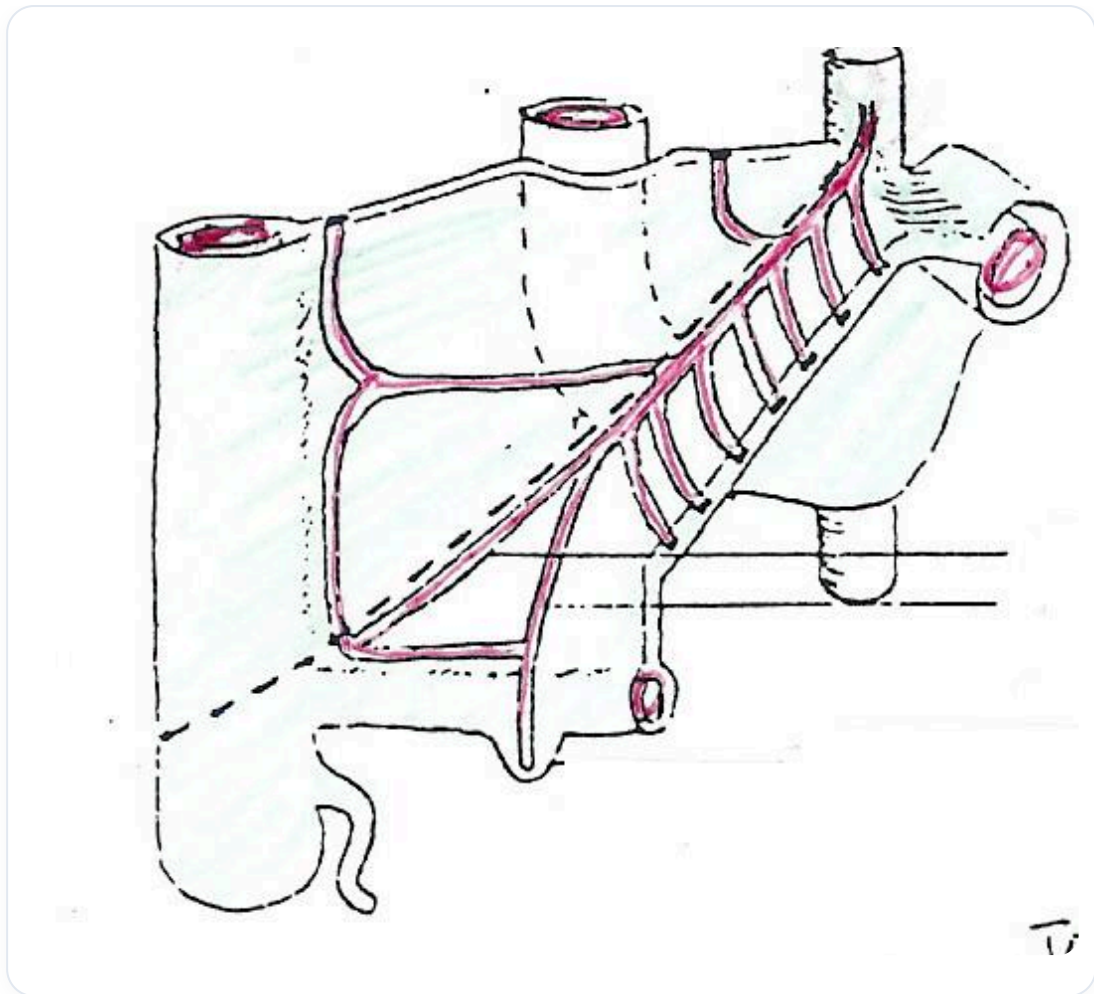


図一 腸管ループの回転

腸の回転は、前方から後方へ**反時計回り**に行われます。これと並行して、**肝胃管**と消化管が形成されます。また、組織に包まれた中胚葉性構造も観察され、これは臍帯レベルでの**将来の役割**、すなわち**卵黄腸管**に対応します。血管はこの領域でさらに発達します。

胃と腸の回転の間には**同期性**が見られます。胃が左に位置すると、肝臓は右に移動します。この動きは心臓も左に配置させ、脾臓のうっ血を引き起こします。**結腸**が膨らみ始め、上腸間膜動脈が腸の発生における基本的な支点となります。

椎骨レベルでは、上腸間膜動脈は**D12-L1**の軸に対応し、これは横隔膜脚の付着部位と関連しています。この支点は身体にとって不可欠であり、腸の成長ダイナミクスに影響を与えます。

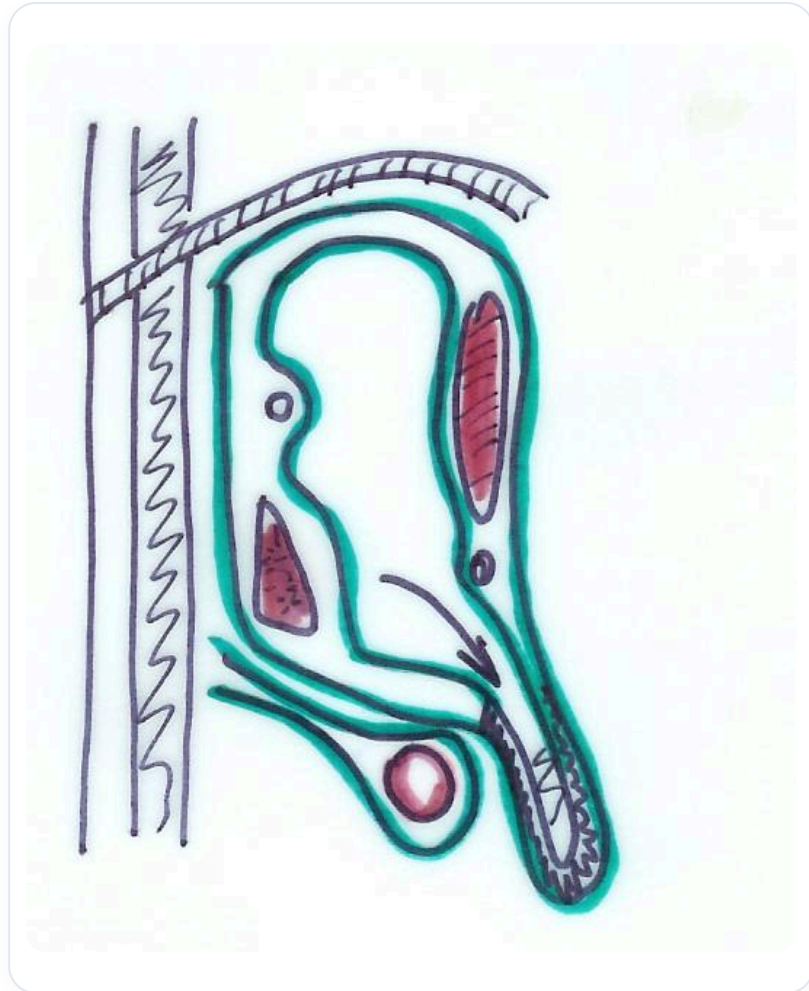


図一 胚の動脈幹

腸の成長は、極性に関連する**異なる速度**によって特徴付けられます。より高い代謝集中が上部に向かって発達する一方、下部は成長が遅く、これにより**左結腸曲**の原基が形成されます。この成長と回転の動きは、腸の形成にとって極めて重要です。

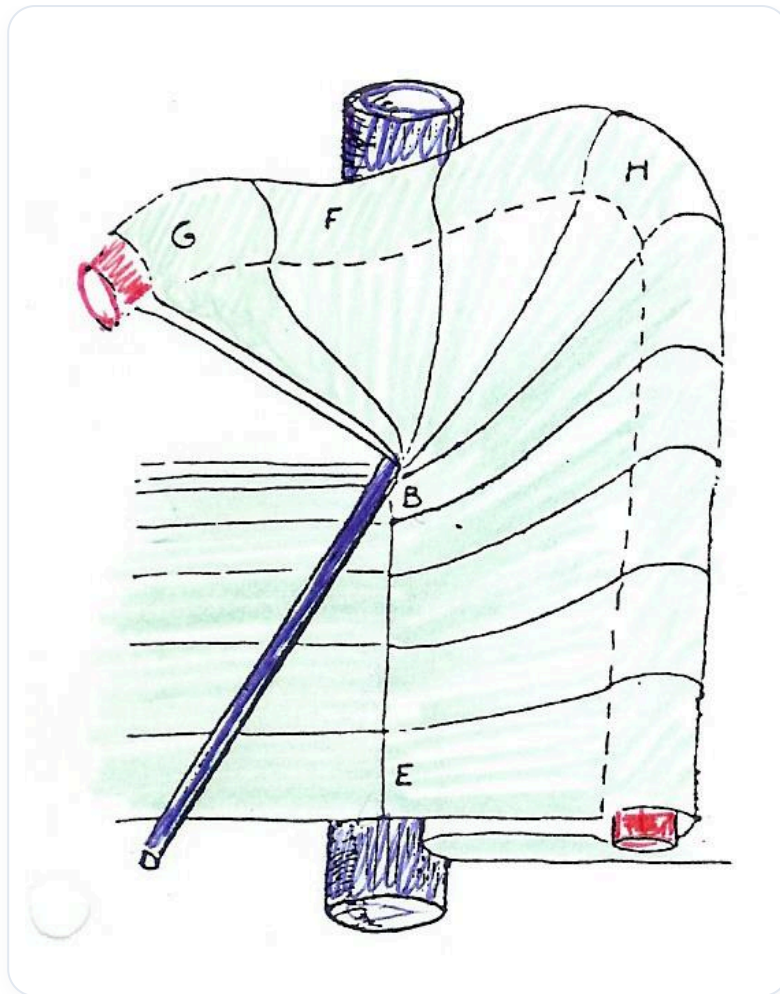
腸のダイナミクスを観察すると、いくつかの重要な支点を特定できます。上腸間膜動脈、左結腸曲、十二指腸枠です。これらの支点は、腸の発生と機能にとって不可欠です。

回転軸である**卵黄腸管**は、恥骨軸と盲腸の間に位置する**メッケル憩室**と呼ばれる遺残物で終わります。脳の発生も消化器血管系に依存しています。栄養供給が不十分な場合、合併症を引き起こす可能性があります。



図一 腸絨毛の循環

腸の再統合は発生の過程で起こり、特に妊娠3ヶ月頃に臍帯が形成され始めます。このプロセスは、特に電解質やホルモンの交換を可能にする**羊膜腔**を介して、母親とのつながりを確立するために重要です。

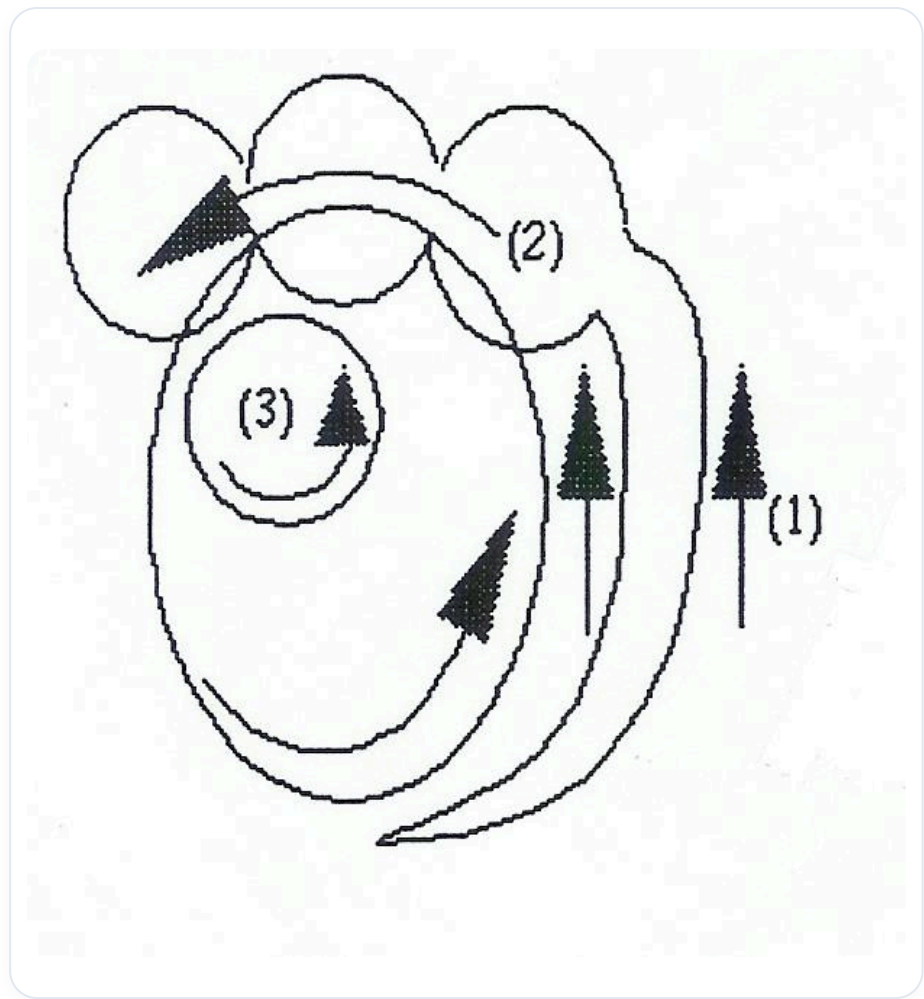


図一 胚の腹側/側方観

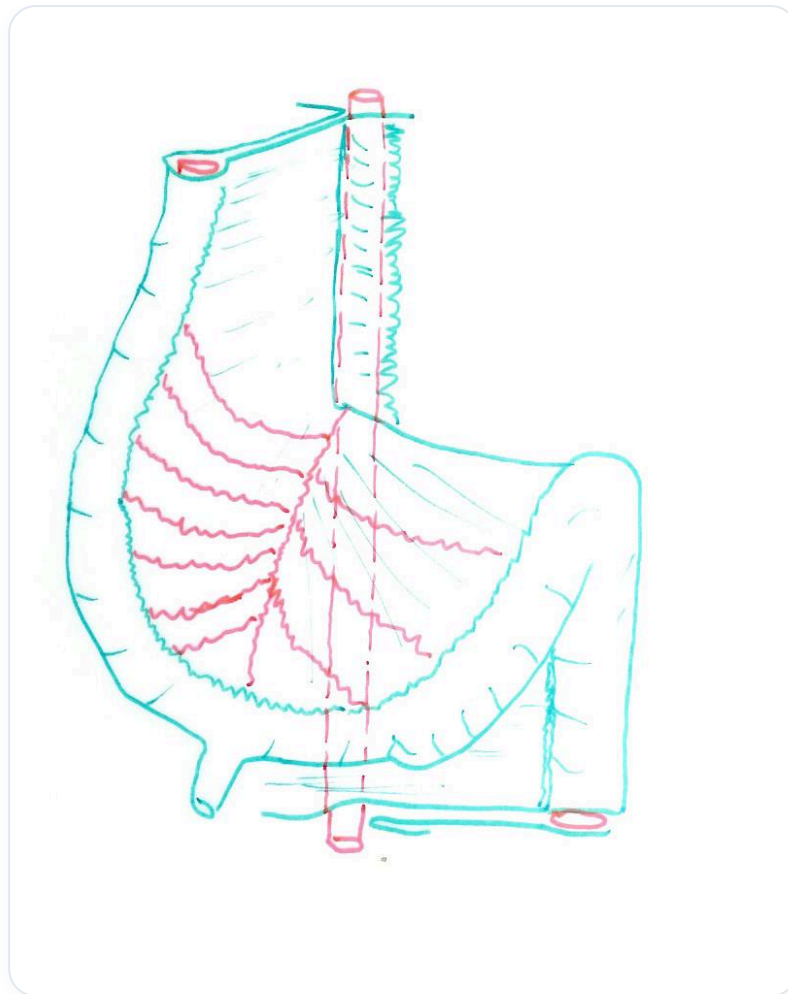
感情や心の状態も腸の健康と関連しています。**上行結腸**は食物の不公平と関連し、**横行結腸**は心の気分を表します。怒りや恐れといった感情は消化器の健康に影響を与える可能性があります。

下行結腸は家族の問題や独立の探求と関連しています。**虫垂**と**盲腸**は免疫防御において重要な役割を果たします。子供の**虫垂炎**などの腸の問題は、胚発生の段階と関連している可能性があります。

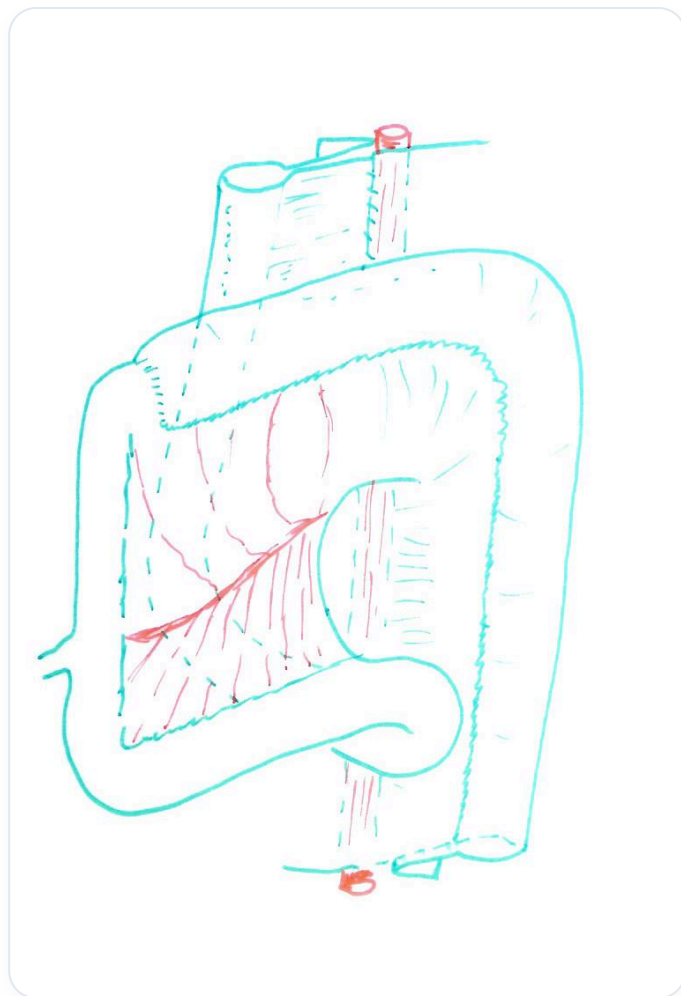
腸疾患の治療には、腹膜のダイナミクスと異なる臓器間の関係を考慮に入れる必要があります。腹膜枠の安定化は、感染症や炎症を含む多くの健康問題を解決するのに役立ちます。



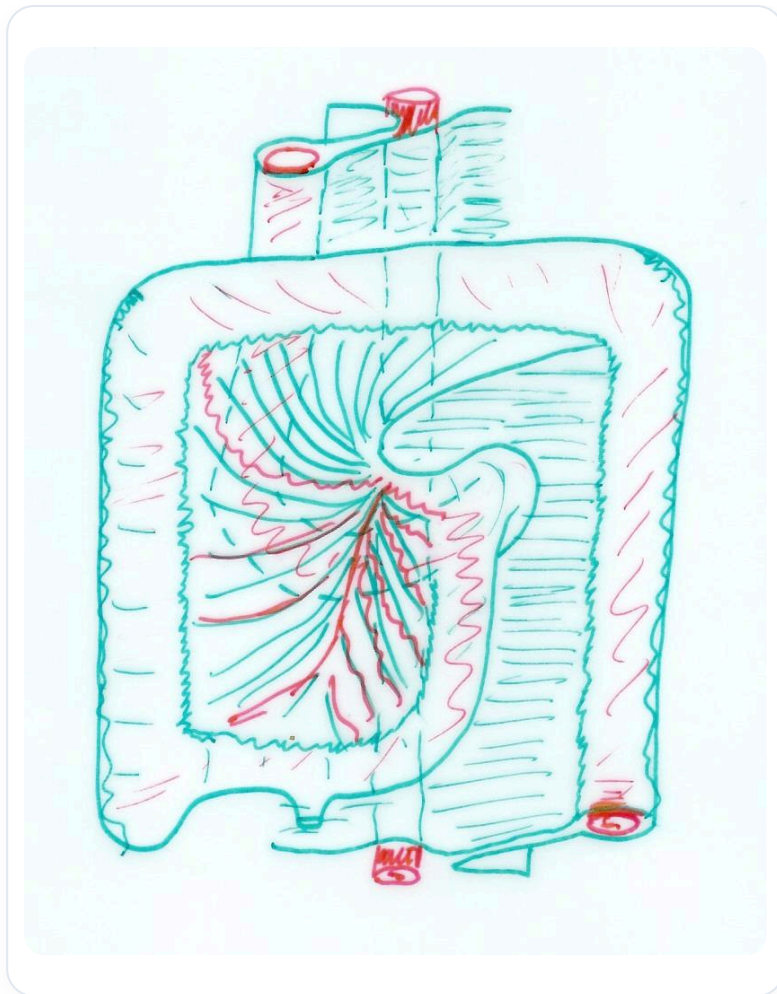
図一 胚の渦



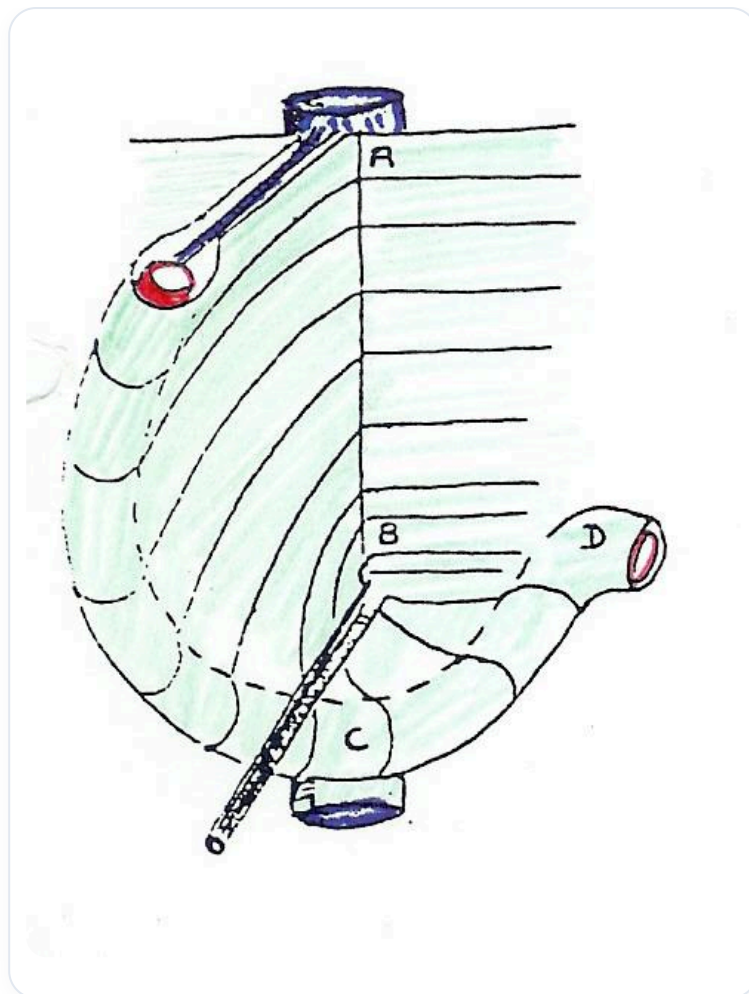
図一 胚の消化器系



圖一 中腸、回轉

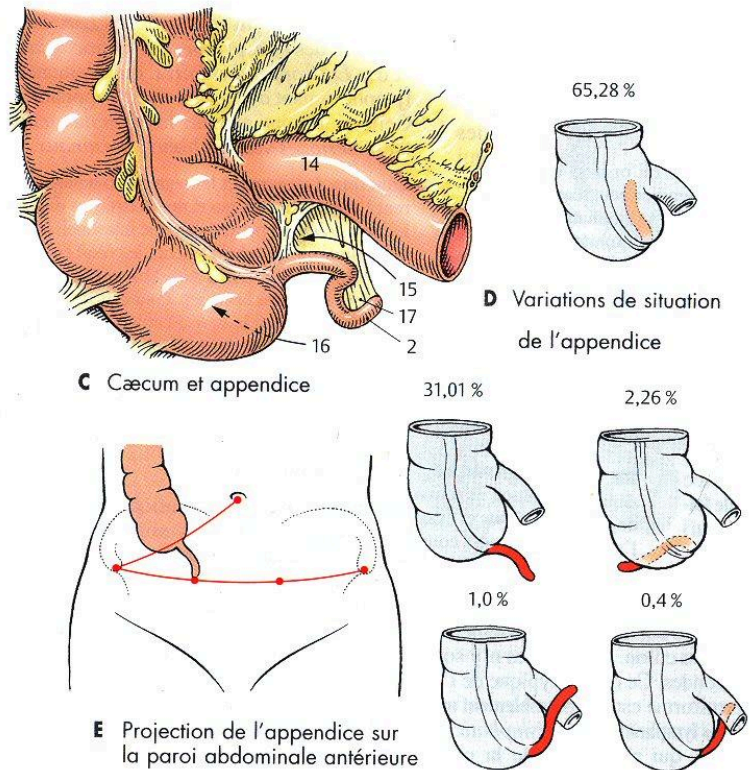


図一 血管を有する小腸

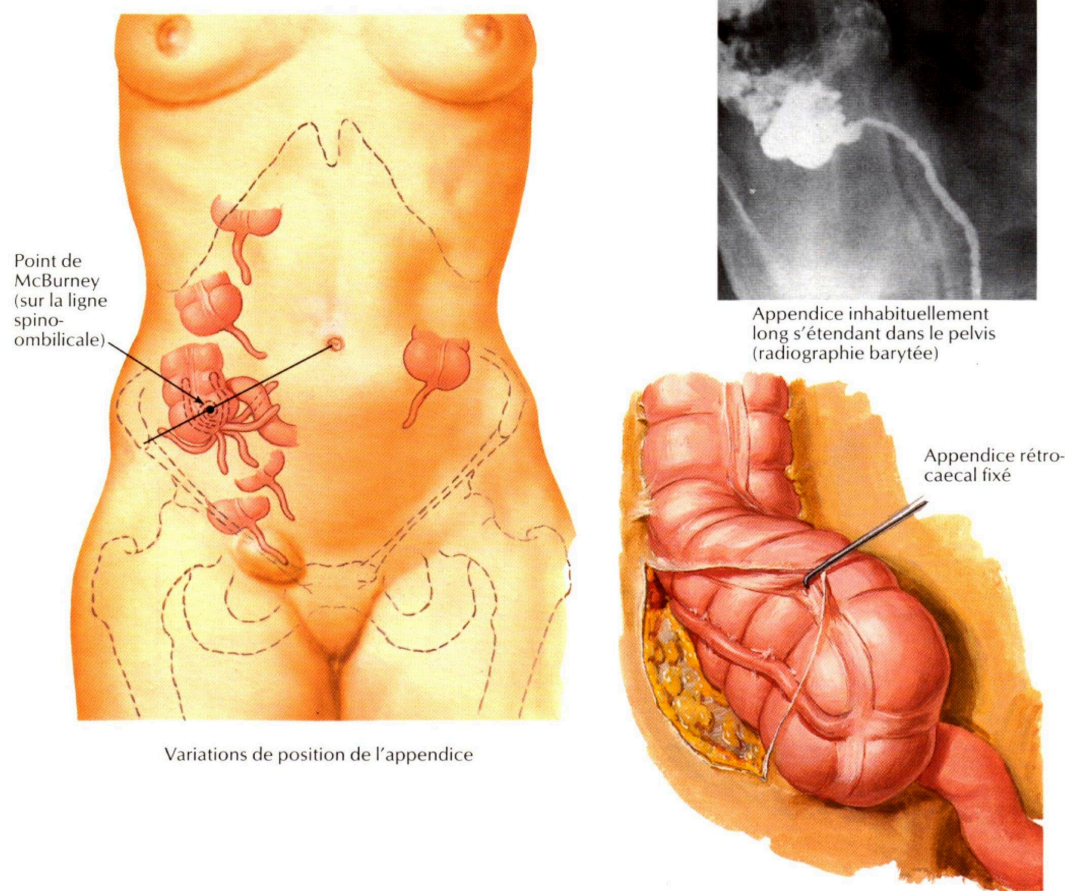


图一 羊水穿刺、胚、子宫

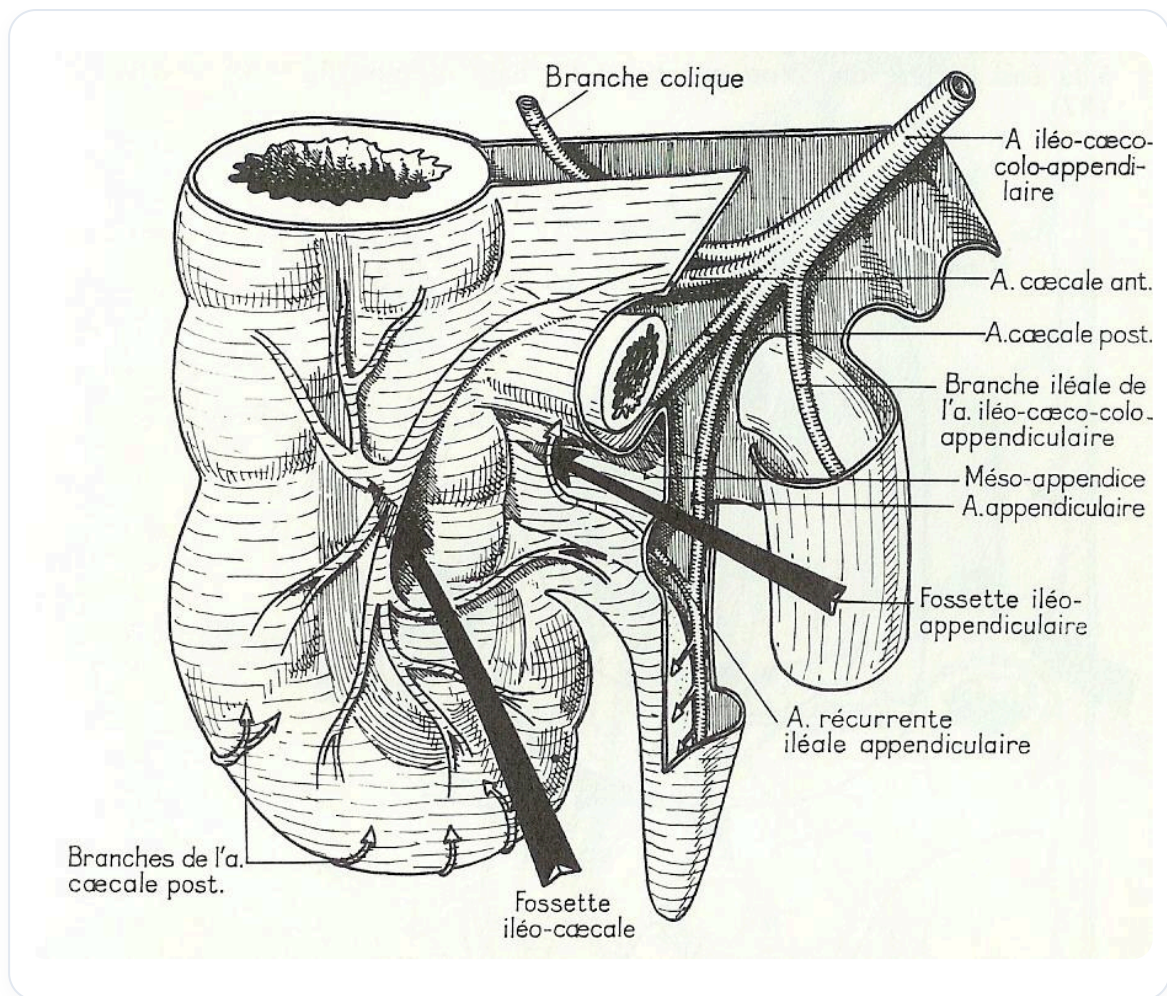
Appendice vermiforme (A-C2). L'appendice prend naissance de l'*extrémité postéro-médiale du caecum*. Sa situation est très variable (**D**) : dans environ 65 p. 100 des cas, l'appendice est refoulé vers le haut derrière le caecum (*situation rétrocaecale haute*) ; dans 31 p. 100 des cas, elle dépasse la linea terminalis dans le petit bassin (*situation basse*) ; dans plus de 2 p. 100 des cas, il est horizontal derrière le caecum (*situation rétrocaecale transversale*) ; chez 1 p. 100 des hommes, il est refoulé vers le haut, en avant de l'iléon (*situation paracaecale, pré-iléale montante*) ; chez environ 0,5 p. 100, il est ascendant derrière l'iléon (*situation paracaecale, rétro-iléale montante*). Dans la **position la plus fréquente (rétrocaecale haute)**, la base de l'appendice vermiforme se projette sur la paroi abdominale antérieure, au **point de McBurney (E)**. Il se situe à la jonction entre le tiers externe et le tiers moyen d'une ligne tendue entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. L'appendice fait en moyenne 10 cm de long et 6 mm d'épaisseur. Les trois ténias du caecum (**C**) partent en étoile de la base de l'appendice, dans la paroi duquel ils forment une *couche musculieuse longitudinale fermée*.



图一 虫垂、盲肠、变异



図一 虫垂の位置



図一 虫垂と盲腸の血管分布